

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех
Индикатор	Доля карманных расходов в структуре общих расходов на здравоохранение
2. Информация об организации	
Организация	РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Общая сумма расходов домашних хозяйств определяется как удельный вес товаров и услуг, потребляемых домашними хозяйствами в структуре ВВП, рассчитанного методом конечного использования. Структура расходов домашних хозяйств на здравоохранение (расходы на услуги больниц, приобретение лекарственных средств и прочее) публикуется в бюллетенях «Расходы и доходы домашних хозяйств Республики Казахстан», «Расходы и доходы населения Республики Казахстан», уполномоченного органа в области государственной статистики по результатам ежеквартальных обследований домашних хозяйств в регионах Республики Казахстан.
Основные понятия:	Частные расходы домашних хозяйств Общие расходы на здравоохранение
Обоснование и толкование	Согласно данным ОЭСР финансовая устойчивость систем здравоохранения определяется уровнем частных расходов на здравоохранение. В 2019 году частные расходы на здравоохранение в Казахстане составили 33,8%, По сравнению со странами ОЭСР, где доля частных расходов от текущих расходов на здравоохранение составляет 26,8%, этот показатель является высоким.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Для расчета частных расходов домашних хозяйств используются следующие источники: 1.Экспресс-информация «ВВП методом конечного использования»; 2.Бюллетени «Расходы и доходы населения Республики Казахстан», «Расходы и доходы домашних хозяйств Республики Казахстан» уполномоченного органа в области государственной статистики; 3.Статистическая форма «Объем розничной торговли по отдельным товарным группам». Для расчета общих расходов на здравоохранение используется Отчет об исполнении государственного

	бюджета уполномоченного органа по исполнению бюджета.
Методы сбора данных	Сбор данных для расчета частных расходов домохозяйств осуществляется Бюро национальной статистики. Сбор данных для расчета общих расходов на здравоохранение осуществляется Уполномоченным органом по исполнению бюджета. Расчет индикатора «Доля частных расходов домашних хозяйств от общих расходов на здравоохранение» осуществляется РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой».
Единица измерения	Процент
Периодичность	Ежегодно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Индекс рассчитывается с помощью среднего геометрического, основанного на методах, используемых для Индекса развития человеческого потенциала. Для расчета показателя 3.8.1 необходимо сначала подготовить 14 индикаторов показателя, чтобы их можно было объединить в индекс, а затем вычислить индекс из этих значений. 14 индикаторов показателя сначала помещаются в один и тот же масштаб, причем 0 является самым низким значением, а 100 - оптимальным. Для большинства показателей эта шкала является естественной шкалой измерения, например, процент младенцев, которые были иммунизированы, колеблется от 0 до 100 процентов. Однако для нескольких индикаторов требуется дополнительное масштабирование для получения соответствующих значений от 0 до 100, а именно: • Повторное масштабирование на основе ненулевого минимума для получения более высокого разрешения (это «растягивает» распределение по странам): распространенность не поднятого кровяного давления и распространенность не употребления табака обе масштабируются с минимальным значением 50%. $\text{пересчитанное значение} = (X-50) / (100-50) * 100$ • Масштабирование для непрерывной меры: средняя глюкоза в плазме натощак, которая является непрерывной мерой (единицы ммоль/л), преобразуется в шкалу от 0 до 100 с использованием минимального теоретического биологического риска (5,1 ммоль/л) и наблюдаемого максимума в разных странах (7,1 ммоль/л). $\text{-пересчитанное значение} = (7.1 - \text{измененное значение}) / (7.1 - 5.1) * 100.$ Максимальные пороговые значения для показателей скорости: плотность больничной койки и плотность рабочей силы здравоохранения ограничены максимальными порогами, а значения выше этого порога поддерживаются на уровне 100. Эти пороговые значения

	основаны на минимальных значениях, наблюдаемых в странах ОЭСР. -пересчитанные больничные койки на 10000 = минимум (100, исходное значение / 18 * 100) -перемасштабированные врачи на 1000 = минимум (100, исходное значение / 0,9 * 100) -измененные психиатры на 100 000 = минимум (100, исходное значение / 1 * 100) -rescaled хирурги на 100 000 = минимум (100, исходное значение / 14 * 100) Когда все значения индикатора показателя находятся в масштабе от 0 до 100, геометрические средства вычисляются в каждой из четырех областей службы здравоохранения, а затем берутся геометрические значения этих четырех значений. Если значение индикатора показателя оказывается равным нулю, оно устанавливается равным 1 (из 100), прежде чем вычислять среднее геометрическое значение.
Комментарии и ограничения:	Необходимо для мониторинга показателя в Отчете о реализации плана развития государственного органа.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны
Уровень дезагрегации:	На уровне республики
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	В соответствии с Системой счетов здравоохранения 2011 (A system of Health Accounts 2011, OECD)
8. Ссылки и документация	Официальная статистика Бюро национальной статистики Отчет по исполнению бюджета уполномоченного органа по исполнению бюджета.